Prancha Visual para o Utente — "O Que Estou a Sentir na Sessão?"

Instrução para o Fisioterapeuta: Mostra esta página no tablet ou mantém impressa em A4 no gabinete para explicar o tratamento ao utente em 30 segundos antes de ligar os canais CH1–CH4.

1. Alívio da Dor (TENS) — "O Efeito Escudo no Nervo"

O que faz: Envia impulsos suaves pela pele que chegam à medula mais rápido do que o sinal da dor, "fechando a porta" ao desconforto e estimulando analgésicos naturais do próprio corpo.

✅ **O que é normal sentir:** Formigueiro contínuo, vibração suave ou pulsação rítmica forte, mas **sempre confortável**.

2. Despertar e Fortalecer o Músculo (NMES / FES / Russa / Aussie)

O que faz: Quando há dor ou após uma cirurgia/lesão, o cérebro "desliga" parte das fibras musculares por proteção (inibição). A corrente ajuda a acordar e recrutar essas fibras em segurança.

✅ **O que é normal sentir:** A corrente sobe devagar, o músculo contrai durante alguns segundos e depois descansa completamente para recuperar.

3. SEMÁFORO DE SENSAÇÃO PARA O UTENTE (AVISE O SEU FISIOTERAPEUTA)

Nível de Sensação	O que o Utente Sente	O que Fazemos na Sessão
🟢 **VERDE (Ideal)**	Formigueiro nítido e agradável (TENS) ou contração muscular firme sem dor (NMES).	Mantemos ou ajustamos ligeiramente se o corpo se habituar (acomodação).
🟡 **AMARELO (Fraco)**	Quase imperceptível ou desapareceu após 3 minutos de tratamento.	Subimos 1 a 2 pontos de intensidade para manter o efeito terapêutico.
🔴 **VERMELHO (Parar)**	Sensação de ardor, picada de agulha num ponto único, cãibra dolorosa ou desconforto.	**Avise de imediato:** pausamos o canal e reposicionamos o elétrodo.

Ficha Clínica de Registo de Eletroterapia em 60 Segundos

IDENTIFICAÇÃO & AVALIAÇÃO RÁPIDA PRÉ-SESSÃO

Nome do Utente: _____ **Data:** ___/___/202__ **Sessão Nº:** ___

Diagnóstico Funcional / Queixa Principal: _____

Escala de Dor Inicial (EVA 0–10): [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] · **Inspeção da Pele:** [ ] Íntegra [ ] Alterada

CONFIGURAÇÃO RÁPIDA DE MAPAS, CANAIS (CH1–CH4) E PARÂMETROS

Região do Atlas: [ ] Cervical [ ] Ombro [ ] Cotovelo/Mão [ ] Lombar [ ] Anca [ ] Joelho/Coxa [ ] Tornozelo/Pé · **Mapa Nº:** #____

Canal	Localização Anatómica / Músculo	Corrente	Freq. (Hz)	Largura (µs)	Rampa / On:Off	mA Máx.
CH1 (Vermelho)		[ ] TENS [ ] NMES [ ] Russa/Aussie	____ Hz	____ µs	____s / __:__	____ mA
CH2 (Azul)		[ ] TENS [ ] NMES [ ] Russa/Aussie	____ Hz	____ µs	____s / __:__	____ mA
CH3 (Verde)		[ ] TENS [ ] NMES [ ] Russa/Aussie	____ Hz	____ µs	____s / __:__	____ mA
CH4 (Amarelo)		[ ] TENS [ ] NMES [ ] Russa/Aussie	____ Hz	____ µs	____s / __:__	____ mA

EVOLUÇÃO COMPARATIVA (ACOMPANHAMENTO DE 5 SESSÕES)

Sessão / Data	Mapa & Corrente	EVA Pré → Pós	Qualidade da Contração / Resposta	Conduta para a Próxima Sessão
S1: __/__	Mapa #__ · _____	__ → __	[ ] Ótima [ ] Moderada [ ] Fadiga	[ ] Manter [ ] Progredir carga/Hz
S2: __/__	Mapa #__ · _____	__ → __	[ ] Ótima [ ] Moderada [ ] Fadiga	[ ] Manter [ ] Progredir carga/Hz
S3: __/__	Mapa #__ · _____	__ → __	[ ] Ótima [ ] Moderada [ ] Fadiga	[ ] Manter [ ] Progredir carga/Hz
S4: __/__	Mapa #__ · _____	__ → __	[ ] Ótima [ ] Moderada [ ] Fadiga	[ ] Manter [ ] Progredir carga/Hz
S5: __/__	Mapa #__ · _____	__ → __	[ ] Ótima [ ] Moderada [ ] Fadiga	[ ] Manter [ ] Progredir carga/Hz

Protocolo de Triagem em 15 Segundos & Bandeiras Vermelhas

🔴 CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS DE LOCALIZAÇÃO (NUNCA APLICAR):

- **Região Cervical Anterior / Seio Carotídeo:** Risco de reflexo vasovagal, queda abrupta da pressão arterial ou laringoespasmo.
- **Aplicação Transtorácica (frente-costas ou lado-a-lado no tórax):** Risco de interferência elétrica cardíaca.
- **Sobre Pacemaker, Desfibrilhador Implantado (CDI) ou Neuroestimulador:** Confirmar sempre presença de dispositivos eletrónicos ativos.
- **Trombose Venosa Profunda (TVP) Ativa ou Tromboflebite:** Risco de deslocamento de trombo pela contração muscular.
- **Região Abdominal/Lombo-Pélvica na Gravidez:** Não estimular sobre o útero gravídico.

🟡 PRECAUÇÕES ESPECIAIS (AVALIAR ANTES)

- **Hipoestesia / Neuropatia Periférica:** Se o utente não sente o estímulo normalmente, não usar a perceção subjetiva como único guia de mA.
- **Implantes Metálicos Superficiais:** Correntes bifásicas simétricas compensadas (TENS/NMES modernos) não geram efeito galvânico químico, mas vigiar densidade de corrente se o metal for muito superficial.
- **Pele Fragilizada, Eczema ou Cicatriz Recente:** Colocar os elétrodos em tecido íntegro adjacente.
- **Epilepsia:** Evitar colocação cervical/cefálica superior sem autorização médica.

🟢 BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ADERÊNCIA

- **Distância entre Elétrodos:** Manter pelo menos o diâmetro de um elétrodo (ou mín. 2–3 cm) para evitar passagem superficial exclusiva.
- **Resistência Cutânea:** Limpar sujidade ou restos de creme analgésico/óleo de massagem antes de colar o elétrodo (evita pontos de queimadura térmica/elétrica).
- **Substituição do Hidrogel:** Elétrodos secos nos bordos concentram toda a corrente no centro (causa nº 1 de picada/ardor).

Mapas de Integração na Consulta: Eletroterapia + Terapia Manual + Exercício

MODELO A — UTENTE COM DOR AGUDA / IRRITABILIDADE ALTA (JANELA ANALGÉSICA)

Objetivo: Baixar a dor nos primeiros 15 minutos para permitir mobilização e exercício ativo sem defesa muscular.

Bloco da Consulta	Intervenção Combinada	Configuração de Referência
Minuto 00–15	TENS Convencional + Posicionamento de Conforto / Crioterapia	80–120 Hz · 100–150 µs · Parestesia forte confortável
Minuto 15–35	Terapia Manual + Mobilização Articular Aproveitando a Janela Analgésica	Pode manter TENS ativo em intensidade suave durante mobilização
Minuto 35–50	Exercício de Controlo Motor sem Dor + Registo Rápido em 60s	Documentar EVA final e resposta funcional

MODELO B — PÓS-OPERATÓRIO OU INIBIÇÃO MUSCULAR (NMES SOBREPOSTO AO EXERCÍCIO)

Objetivo: Somar o recrutamento elétrico (NMES/Russa/Aussie) à contração voluntária do utente para vencer a inibição artrogénica.

Bloco da Consulta	Intervenção Combinada	Configuração de Referência
Minuto 00–10	Aquecimento Articular + Libertação Miofascial / Mobilização Patelar	Preparar pele antes de usar óleos na zona dos elétrodos
Minuto 10–30	**NMES + Exercício Ativo Sincronizado:** O utente contrai voluntariamente sempre que sente a rampa de subida ("On") da corrente	35–50 Hz · 250–400 µs · Rampa 2s · On 6–10s / Off 12–20s (1:2 ou 1:3)
Minuto 30–50	Treino Funcional / Marcha / Estabilidade + Registo na Ficha Clínica	Vigiar sinais de fadiga; encerrar se a qualidade do movimento cair